

奥美拉唑的不良反应及与其他药物相互作用分析

王丽娟

(黑龙江省眼病防治所, 黑龙江 哈尔滨 150007)

【摘要】目的 探讨奥美拉唑的不良反应及与其他药物相互作用分析。**方法** 选取我院接受治疗的消化性溃疡患者68例, 随机将其分为观察组和对照组, 各34例。观察组患者采用奥美拉唑联合奥曲肽进行治疗, 对照组患者采用法莫替丁进行治疗。**结果** 观察组的不良反应发生率(11.76%)明显低于对照组(20.59%), 差异有统计学意义($P<0.05$)。**结论** 奥美拉唑联合其他药物共同对患者进行治疗, 可能会发生协同作用, 所以在患者采用奥美拉唑进行治疗时应在医生的指导下服用, 服用后密切注意患者不良反应的发生, 从而确保用药的安全性和有效性。

【关键词】 奥美拉唑; 不良反应; 药物相互作用; 分析

【中图分类号】 R917

【文献标识码】 B

【文章编号】 ISSN. 2095-8803. 2017. 35. 71. 02

DOI:10.16484/j.cnki.issn2095-8803.2017.35.051

奥美拉唑属于治疗消化性疾病的常用药物, 近年来, 在临床治疗中, 奥美拉唑的使用率越来越高, 主要用于治疗消化性溃疡、十二指肠溃疡、反流性食管炎等, 使用后患者出现不良反应的报道也逐渐增多, 从而引起了人们极大的关注^[1]。此次研究选取我院接受治疗的消化性溃疡患者68例, 治疗效果较为理想, 现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2016年1月~2017年1月间在我院接受治疗的消化性溃疡患者68例, 男49例, 占总人数的72.06%, 女19例, 占总人数的27.94%, 年龄19~69岁, 平均年龄(41.42 ± 10.51)岁, 病程2个月~6年, 平均病程(3.14 ± 1.32)年。68例患者均通过胃镜检查确诊为消化性溃疡, 其中有34例患者为十二指肠球部溃疡, 22例患者为胃溃疡, 12例患者为复合型溃疡。将68例患者随机分为观察组和对照组, 各34例。两组患者在年龄、性别、病程等方面进行比较, 两组数据, 差异无统计学意义($P>0.05$)。

1.2 方法

观察组患者采用奥美拉唑(上海美优制药有限公司, 国药准字H20113502)联合奥曲肽(北京百奥药业有限责任公司, 国药准字H20061310)进行治疗, 奥美拉唑口服, 每天1~2次, 每次20mg。奥曲肽0.025mg/h, 采用静脉滴注的方法

进行治疗。对照组患者采用法莫替丁(上海世康特制药有限公司, 国药准字H20067930)进行治疗, 法莫替丁, 口服, 每天2次, 每次20mg。两组均坚持用药28天为1个疗程。

1.3 判断标准

观察并记录患者所出现的不良反应, 全部患者在治疗前后均检查血、便、尿常规, 肝、肾功能, 凝血酶原活动度及电子胃镜检查。

1.4 统计学方法

两组数据均采用SPSS11.0软件进行统计学处理, 计量资料采用“ $\bar{x} \pm s$ ”表示, 采用 χ^2 检验, 计数资料采用百分数(%)表示, 采用 t 检验, 以 $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者不良反应发生情况

观察组34例患者中, 有2例患者腹泻, 1例患者头痛, 1例患者嗜睡, 不良反应发生率为11.76%。对照组34例患者中, 有2例患者肝功能异常, 2例患者皮疹, 1例患者荨麻疹, 1例患者腹泻, 1例患者头痛, 不良反应发生率为20.59%。两组数据, 差异有统计学意义($P<0.05$)。

2.2 两组患者不良反应发生率与患者年龄、性别的关系

男性消化性溃疡的不良反应发生率高于女性患者, 数据差异有统计学意义($P<0.05$); 46~59岁患者不良反应发生率明显高于其他年龄段的患者, 差异有统计学意义($P<0.05$)。详见表1。

表1 两组患者不良反应发生率与患者年龄、性别的关系

组别	n	性别		年龄			
		男	女	≤20	21~45	46~59	≥60
观察组	4	3 (75.00%)	1 (25.00%)	1 (25.00%)	1 (25.00%)	2 (50.00%)	0
对照组	7	6 (85.71%)	1 (14.29%)	1 (14.29%)	1 (14.29%)	3 (42.86%)	2 (28.57%)

3 讨论

此次研究中, 患者出现不良反应主要表现为腹泻、腹痛、恶心、便秘、胃胀气、皮疹、失眠、嗜睡等, 因不良反应均不明显, 无需对其进行治疗。使用奥美拉唑的患者不良反应发生率明显低于使用法莫替丁的患者。患者口服奥美拉唑后, 部分患者表示肠胃消化系统产生不适, 产生

不适的患者症状较轻, 停药后症状得到缓解。

有研究表明, 口服奥美拉唑后, 可能会引起患者急性尿潴留、间接性肾炎、血尿, 所以在临床治疗中, 对老年患者或肝肾功能不全类的患者给药时要小心谨慎, 留意观察。奥美拉唑容易造成低酸环境, 从而使地高辛分解为药效维持较短且活性较低的代谢物, 会对患者的临床治疗效

果产生严重影响, 停止服用奥美拉唑后10天左右, 患者胃酸分泌才能恢复到正常。

综上所述, 奥美拉唑是一种质子泵抑制剂, 可以较为持久的抑制基础胃酸及食物, 五肽胃泌素所导致的胃酸分泌的作用, 奥美拉唑在临床治疗消化性溃疡有着较为理想的治疗效果, 但奥美拉唑容易诱发患者产生不良反应。奥美拉唑联合其他药物共同对患者进行治疗, 可能会发生协同作用, 所以在患者采用奥美拉唑进行治疗时应在医生的指导下服用, 服用后密切注意患者不良反应的发生, 从而确保用药的安全性和有效性。

(上接第68页)

优化了常规西药治疗, 提升了常规西药治疗的治疗效果, 在原发性痛经治疗方面具备应用优势。

综上所述, 在原发性痛经治疗方面, 中医针灸治疗配合常规西药治疗能够发挥出比单纯的常规西药治疗更佳的治疗效果, 因而应该在临床方面大力推广。

(上接第69页)

最多, 为88.15%, 知道UAE的仅占32.22%, 说明医学研究生对此病治疗方式的认知上仍比较传统局限。调查中还发现, 相较于学术型研究生, 专业型研究生对于CPS更为了解, 其原因可能是专业型研究生平时在医院实习, 培养更加注重临床疾病的诊疗等方面, 而学术型研究生平时主要在学校进行科研工作, 少有机会接触病人且对于临床知识知道的也相对较少。

参考文献

- [1] 陈毅, 谢春明, 冯对平, 等. 子宫动脉化疗栓塞术和UAE治疗

参考文献

- [1] 段谦. 奥美拉唑的不良反应及与其他药物的相互作用[J]. 中国当代医药, 2011, 18(10): 50-50, 53.
- [2] 冯洁颖. 奥美拉唑所致的不良反应及其与其他药物的相互作用特点分析[J]. 中国现代药物应用, 2012, 06(16): 71-72.
- [3] 苏选优. 奥美拉唑所致的不良反应及其与其他药物的相互作用特点分析[J]. 中外医学研究, 2014, (22): 134-135, 136.

参考文献

- [1] 吴艳龙. 中医针灸治疗原发性痛经的疗效观察[J]. 实用妇科内分泌杂志(电子版), 2016, 3(7): 56-56.
- [2] 刘关章. 中医针灸治疗原发性痛经的疗效观察[J]. 临床医药文献电子杂志, 2017, 4(13): 2413-2414.

(上接第70页)

感染迹象, 则需要停止应用抗生素, 在进入产程之后在继续使用, 这样能够显著降低新生儿感染率和绒毛膜羊膜炎等。

综上所述, 对于未足月胎膜早破患者来说需要尽早使用抗生素治疗, 能够显著降低感染风险, 改善母婴结局。

参考文献

- [1] 李红, 黄小清. 未足月胎膜早破不同时间应用抗生素治疗对分

子宫瘢痕妊娠的临床效果比较[J]. 中华介入放射学电子杂志, 2016, 4(03): 158-161.

- [2] 曹满瑞, 何健龙, 刘炳光, 等. 剖宫产疤痕妊娠的子宫动脉栓塞并清宫治疗[J]. 临床放射学杂志, 2009, 28(4): 553-555.
- [3] Litwicka K, Greco E. Caesarean scar pregnancy: a review of management options[J]. Curr Opin Obstet Gynecol, 2011, 23(6): 415-421.
- [4] Li C, Li C, Feng D, et al. Transcatheter arterial chemoembolization versus systemic methotrexate for the management of cesarean scar pregnancy[J]. Int J Gynaecol Obstet, 2011, 113(3): 178-182.

娩结局的影响[J]. 中国药物经济学, 2017, 12(06): 56-58.

- [2] 王永芹, 李淑红, 袁新燕. 糖皮质激素对抗生素治疗未足月胎膜早破效果的作用分析[J]. 大家健康(学术版), 2016, 10(06): 146.
- [3] 周子球, 杨彩虹, 林方等. 抗生素应用时间对未足月胎膜早破母婴结局的影响探究[J]. 现代诊断与治疗, 2015(10): 2243-2245.